

诺诚健华1类创新药奥布替尼 获国家药监局批准上市

近日,国家药品监督管理局通过优先审评审批程序附条件批准北京诺诚健华医药科技有限公司申报的1类创新药奥布替尼片(商品名:宜诺凯)上市,适用于治疗:①既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者。②既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者。

奥布替尼是诺诚健华自主研发的1类创新药,是具高度选择性的新型BTK抑制剂,用于治疗淋巴瘤及自身免疫性疾病,并获得国家重大新药创制专项立项支持。在针对复发/难治性MCL和复发/难治性CLL/SLL的2个临床研究中,奥布替尼显示了良好的总缓解率 and 安全性。

根据奥布替尼单药治疗复发/难治性CLL/SLL中国患者II期研究的更新数据显示,总缓解率(ORR)为91.3%,大多数不良事件为轻度至中度,时间扩展的随访分析未发现新的安全性问题。根据奥布替尼单药治疗复发/难治性套细胞淋巴瘤中国患者多中心、开放性、长期安全性和有效性研究的最新数据显示,总缓解率(ORR)为87.9%,93.9%患者实现疾病控制。在治疗R/R MCL患者中显示出了良好的疗效和安全性。

赛诺菲/再生元抗PD-1疗法Libtayo 获美国FDA批准用于治疗 PD-L1高表达肺癌

赛诺菲(Sanofi)与再生元(Regeneron)近日联合宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已批准抗PD-1疗法Libtayo(cemiplimab),用于一线治疗肿瘤高表达PD-L1肿瘤比例得分(TPS)≥50%、有转移性或局部晚期肿瘤、不适合手术切除或根治性放疗、肿瘤无EGFR、ALK或ROS1畸变的晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者。

此次批准,是基于一项开放标签、随机、多中心III期试验EMPOWER-Lung 1研究的数据。该研究在≥50%的肿瘤细胞中检测出PD-L1表达阳性的鳞状或非鳞状晚期NSCLC患者中开展,比较了Libtayo单药疗法与含铂双效化疗用于一线治疗的疗效和安全性。结果显示,在整个患者群体中,与化疗相比,Libtayo将死亡风险降低了32%($HR = 0.68; P = 0.0022$),延长了总生存期(中位OS:22个月 vs. 14个月);将疾病进展或死亡风险降低了41%($HR = 0.51; P < 0.0001$),延长了无进展生存期(中位PFS:6.2个月 vs. 5.6个月)、提高了客观缓解率(ORR:37% vs. 21%)。

国家药监局关于修订曲马多单方口服剂说明书的公告

为进一步保障公众用药安全,国家药品监督管理局决定对曲马多单方口服剂说明书进行修订。其中【不良反应】【禁忌】【注意事项】的修改要点摘取如下:

【不良反应】项应包含且不限于以下内容:消化系统损害:恶心、呕吐、胃不适、腹痛、腹泻、腹胀、腹部不适、口干、呃逆、便秘、肝功能异常。神经和精神障碍:头晕、眩晕、头痛、抽搐、震颤、麻木、嗜睡、失眠、食欲异常(如食欲不振等)、幻觉、谵妄、烦躁、惊厥、癫痫发作、药物依赖、意识障碍,严重者可致昏迷。皮肤及其附件损害:瘙痒、皮疹(如红斑疹、荨麻疹、斑丘疹等)、多汗。全身性损害:乏力、寒战、发热(高热)、血管神经性水肿,严重者可致晕厥。

【禁忌】项应包含且不限于以下内容:对曲马多或本品中其它成分或阿片类药物过敏者。12岁以下儿童。有严重呼吸抑制、严重脑损伤、意识模糊、急性或严重支气管哮喘者(无复苏设备或未进行监测)。已知或疑为胃肠道梗阻者,包括麻痹性肠梗阻。酒精、安眠药、麻醉剂、中枢镇痛药、阿片类或精神药物急性中毒者,本品可加重这些患者的中枢、呼吸系统抑制。

【注意事项】应包含且不限于以下内容:肝肾功能不全者酌情减量使用或延长给药时间间隔。长期使用不能排除产生耐药性或药物依赖性的可能。禁止作为对阿片类有依赖性患者的代用品,因不能抑制吗啡的戒断症状。突然撤药可能导致戒断症状,建议缓慢减药。

英国警示红霉素因心脏风险(QT间期延长) 需慎用以及与利伐沙班的药物相互作用

近日,英国药品与健康产品管理局(MHRA)发布消息称,红霉素与QT间期延长引发的事件有关,例如心脏骤停和心室纤颤。有QT间期延长或室性心律失常(包括尖端扭转型室性心动过速)史或电解质紊乱的患者不应使用红霉素。利伐沙班与红霉素之间潜在的药物相互作用也可能导致出血风险增加。

给医务人员的建议:①注意大环内酯类抗生素的心脏毒性(QT间期延长),特别是红霉素和克拉霉素。②红霉素不应用于以下患者:有QT间期延长(先天性或有记录的获得性QT间期延长)或室性心律失常(包括尖端扭转型室性心动过速)病史;电解质紊乱(低钾血症或低镁血症)。③当给有心脏事件风险增加的患者开具处方时,应考虑对抗心脏风险的治疗潜在益处,有以下情况的患者需慎用:心脏病或心力衰竭、传导障碍或临床相关的心动过缓、同时使用其他与QT间期延长相关的药物的患者。④引导患者阅读患者信息手册,并提醒高危患者如果出现心脏事件的体征或症状,请务必就医。⑤红霉素广泛应用于儿童,其中一些儿童可能有QT间期延长,因此要考虑儿童的病史,平衡治疗获益与潜在风险。

此外,红霉素可能与利伐沙班发生相互作用并增加出血风险,在处方抗生素时应考虑这种相互作用,如果需要同时使用,请遵循产品信息中的预防措施。